

STEP 2 환자 교육

공감	피로한 증상이 시간이 지나도 나아지지 않아 걱정이 많이 되셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 000 한 이유로 현재 만성 피로증후군이 가장 의심됩니다. 이 질환은 신체에 다른 원인 없이 환자분께서 보이는 피로, 000 증상들 4가지 이상이 동시에 지속적으로 나타날 때 진단을 내릴 수 있습니다.
감별 진단	환자분께서 현재 신체적 원인이 없더라도 다른 증상이 없지는 않은지 나타날 때까지 한동안 지켜보는 것이 필요합니다. 기질적인 원인의 질병으로 B질환, C질환 등 다른 기저 질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 전체혈구검사, 갑상샘기능검사, 간기능검사, 혈중 코티솔 농도 검사, 결핵반응검사, 흉부 엑스레이, 혈중철농도검사를 해보도록 하겠습니다.
치료	만약 검사 후 특별한 기저 질환 없이 피로하다면 항우울제나 인지 행동 치료가 도움이 될 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 교정] 피로의 가장 중요한 치료는 생활 습관의 교정입니다. 극복 가능한 정도의 적절한 유산소 운동을 하루 30분씩이라도 규칙적으로 하시는 것이 도움이 많이 됩니다. 또한 음주와 늦은 시간에 야식을 먹는 것은 피로를 악화시킬 수 있으므로 줄이는 것이 좋습니다. [약물 위험성 교육] 약물은 처방해드린 것 이상으로 드시지 마시고, 수면을 방해할 수 있으니 커피도 많이 드시지 마세요. [수면 위생] 수면 환경은 조용하고 쾌적하게 유지해 주시고, 잠이 안 올 때에는 계속 누워 있기보다 침실 밖으로 나와서 명상을 하거나 따뜻한 물을 한 잔 마셔주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, TFT, LFT, fasting serum glucose
- ② Thyroid scan, 수면다원검사, EKG, BDI(우울증 척도검사), Chest X-ray(결핵),
객담도말검사, AFB 검사

❖ 치료 계획

- ① 인지행동 치료
- ② 만성 피로증후군 : 항우울제, 저용량 부신겉질 호르몬
- ③ 수면장애 : 수면 환경 개선
- ④ 철결핍빈혈 : 철분제 보충

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 환자가 극복 가능한 적절한 유산소성 운동 권장
- ② 약물 남용 금지하고, 커피도 많이 마시지 말 것
- ③ 수면장애가 심한 경우 수면다원검사 등 추가적 검사를 받고 수면 위생을 잘 지키도록 교육
- ④ 원인이 밝혀지지 않은 경우 추가적인 검사 및 추적 관찰이 필요함을 교육
- ⑤ 종양과 같은 기질적 원인이 의심되는 경우 그에 대한 검사가 필요함을 교육



keyword

주의 신체적 원인이 없더라도 정신적 원인이라 강조하지 않습니다.

참고 멘트 “의학적으로 특별한 이상 소견은 없습니다만, 그렇다고 아무 문제가 없다는 것은 아닙니다. 다른 증상이 나타날 때까지 한동안 지켜보는 기간이 필요합니다. 심리적인 문제의 경우 저절로 회복되는 것을 기대할 수도 있습니다.”

피로의 지속 기간에 따라 급성 피로, 만성 피로를 구분하고, 피로의 유발 원인 유무에 따라 기질성 피로, 약물/독소 유발, 원인불명 피로 등 감별하기

문진 : 복용 중인 약, 최근 건강 검진 여부 묻기, 정신과 질환(우울/불안, 수면장애, 퇴행성 질환) 감별해야 하는 것 잊지 말기

신체 진찰 : 갑상샘저하증 감별하기 위해 목 진찰하는 것 잊지 말기

환자 교육 : 규칙적 운동, 음주 줄이기, 야식 끊기 등 생활 습관의 교정, 카페인 섭취를 포함한 약물 과다 섭취 피하기, 수면 위생에 대해 교육하기



1) 가장 핵심이 되는 만성 피로와 관련된 증상은 다음과 같이 정의된다.

- 임상적으로 평가되었고, 설명이 되지 않는 새로운 피로가 6개월 이상 지속적 혹은 반복적으로 나타나고
- 현재의 힘든 일 때문에 생긴 피로가 아니어야 하고
- 휴식으로 증상이 호전되지 않아야 하고
- 만성 피로 때문에 직업, 교육, 사회, 개인 활동이 증상이 나타나기 이전에 비해 실질적으로 감소해야 한다.

2) 1)의 피로 이외에 다음 증상들 중 4가지 이상이 동시에 6개월 이상 지속되어야 한다.

[인기다경 근두운잠]

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ① 인후통 | ② 기억력 혹은 집중력 장애 |
| ③ 다발성 관절통 | ④ 경부 혹은 액와부 림프샘 압통 |
| ⑤ 근육통 | ⑥ 새로운 두통 |
| ⑦ 운동 혹은 힘들여 일을 하고 난 후 나타나는 심한 권태감 | |
| ⑧ 잠을 자도 상쾌한 느낌이 없음 | |

3) 하지만 위의 증상들이 다음 나열되는 질환에 의한 것이면 만성 피로증후군에 해당되지 않는다.

- 만성 피로를 설명할 수 있는 현재 증상의 모든 기질적 질환 : 갑상샘저하증, 빈혈, 각종 만성 질환, 부신결절기능저하증, 수면무호흡증, 기면발작, 약물 부작용 등
- 과거에 진단되었지만 회복이 증명되지 않았고, 지속되었을 때 만성 피로를 설명할 수 있는 모든 기질적 질환
- 정신과적인 주요 우울증, 양극성 정동성 장애, 조현병(정신분열증), 망상장애, 치매, 신경성 식욕부진, 대식증
- 만성 피로가 시작되기 2년 전부터 그 이후에 생긴 알코올 혹은 기타 약물 남용
- 심한 비만(체질량 지수 45 이상)

[네이버 서울대병원 의학정보]

시험 관경 코멘트



체중 감소의 경우 키, 몸무게, 허리둘레를 정확하게 확인하고, 얼마만큼의 기간 동안 몇 kg가 빠졌는지 확인하는 것이 우선입니다. 6~12개월 사이에 5% 이상의 체중 변화나 5kg 이상 감소, 혹은 한 달에 2kg 이상의 체중 감소가 있을 경우 의미 있는 체중 변화로 간주할 수 있습니다. 이후 수의적, 불수의적 원인으로 나누어 운동량과 식사량의 변화를 확인하여 의도적으로 식사량을 줄여 체중을 줄인 경우나 씹는 데에 장애가 있어 먹지 못한 경우 등을 먼저 감별해야 합니다. 이후 불수의적 원인으로 호흡기/내분비/소화기로 나누어 생각하고, 암의 가능성을 떠올리며 질문하면 좋습니다.

식습관과 평소 운동 습관에 대해 꼼꼼히 물어본 뒤 교육 시간에 개선해야 할 점을 상세하게 알려주면 환자-의사 관계가 좋아질 것입니다. 신체 검진에서는 환자가 호소하는 증상에 맞게 필요한 신체 검진을 선택적으로 시행해야 합니다.

결핵이 의심될 경우 흉부 진찰을 full로 하도록 합니다. 교육 시에는 의미 있는 체중 감소를 설명하고, 체중이 더 빠지기 전에 병원에 잘 왔다고 환자에게 안심시킨 후 열량 섭취 부족하지 않도록 하루 3끼 규칙적이고 충분한 식사를 하도록 교육합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

* 의미있는 체중 저하 : 6~12개월 사이에 5% 이상의 체중 변화나 5kg 이상 감소/한 달에 2kg

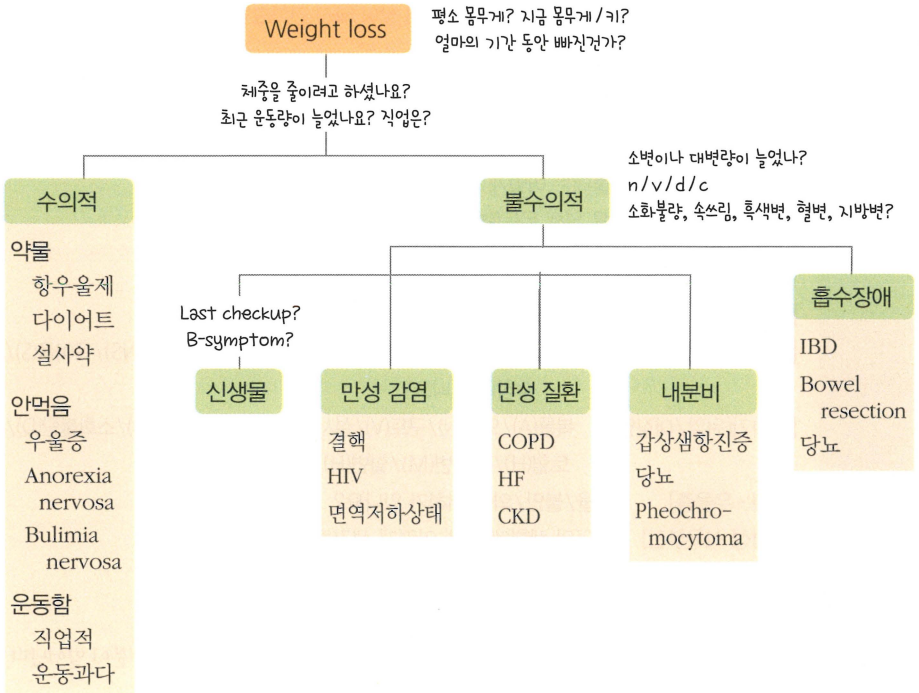
1) 체중 감소가 의미있는지? 2) 수의적/불수의적? 3) 칼로리 섭취가 감소했는지? 먼저 확인

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성	일차성 체중 감소	[병력] 스트레스 해소와 식습관 개선을 통해 체중 증가 필요	[치료] 생활 습관 개선
약물	약물 유발 체중 감소	[병력] 설사약 등	[치료] 약물 중단
호흡기	폐결핵★ (tuberculosis)	[병력] 발열, 객혈, 피로, 체중 감소, 야간 발한, 이전에 결핵 걸렸던 적 있음 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 객담 항산염색, 투베르쿨린 검사 [치료] 항결핵제(Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, Ethambutol)

호흡기	만성 폐쇄 폐질환 (chronic obstructive pulmonary disease) /폐암	[병력] 고령, 가래, 흡연자, 호흡곤란, 객혈 [검진] 흉부 청진에서 싹싹거림 가능	[검사] 폐기능검사, CXR, ABGA [치료] SABA, LABA, LAMA, 산소 치료
내분비	당뇨병★ (diabetes)	[병력] 다뇨, 다갈, 체중 감소, 피로, 소변에서 단백, 가족 중 당뇨 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 소변검사 [치료] Metformin 등 혈당강화제, 인슐린 주사, 식습관 조절
	갑상샘항진증★ (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 설사, 피로 [검진] 갑상샘 촉진	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole, 방사성 요오드 치료
	크롬친화세포종 (pheochromocytoma)	[병력] 두통, 안면 홍조, 발한, 두근거림, 식은땀, 기립성 저혈압 [검진] 복부 촉진	[검사] 24시간 요중 메타네프린, 복부 CT [치료] Phenoxybenzamine, Propranolol, 부신절제술
소화기	위암/대장암	[병력] 체중 감소, 소화불량, 혈변/흑색변, 이전 위내시경에서 궤양 [검진] DRE	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경적 점막 하절제술, 항암 치료
	짧은장증후군 (short bowel syndrome)	[병력] 이전 수술로 장 절제함 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 복부초음파, 단순 복부 방사선 촬영 [치료] TPN, 지사제, Cholestyramine
	염증 장질환★ (IBD)	[병력] 혈변, 심한 복통, 탈수, 체중 감소 [검진] 복부 압통, 장음 감소, DRE 혈변	[검사] 대장내시경, 대장조영술, 복부 CT [치료] 설파살라진, 스테로이드, Infliximab, 충분한 영양 공급
기타	기생충 감염	[병력] 해외여행력, 익히지 않은 음식 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 대변검사 [치료] 구충제(praziquantel)
정신	우울증	[병력] 우울, 의욕 저하, 식욕부진, 수면장애, 죄책감, 집중력 저하, 사고력장애, 정신운동초조	[검사] Beck의 우울척도검사 [치료] SSRI, TCA, 전기경련요법

정신	신경성 식욕부진★ (anorexia nervosa)	[병력] 타의로 내원, 본인이 살았다고 생각, 젊은 여성, 생리 불규칙, 구토제 사용 [검진] 구토 흔적(Russel's sign)	[검사] 전해질검사 [치료] 영양 공급 및 입원 치료
----	---------------------------------	--	--

증례별 알고리즘



Physical

신장/체중 측정 → BMI 계산
피부, 구강, 혀, 치아 상태 확인
눈(창백? 황달? 돌출?)

갑상샘 비대?
목이나 겨드랑이 림프절
가슴 청진(심폐 기능)

다리 오목부종
복부 진찰(시청타촉, 간비종대, 종괴)
DRE(if needed)

기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 체중이 빠지기 시작했나요?/체중이 빠진 것을 안게 언제였나요? 체중이 얼마나 줄었나요?
L	살이 특히 더 빠진 부위가 있나요?
D	지속적으로 살이 빠지셨나요?/아니면 갑자기 살이 빠진 건가요?
Co	몇 kg에서 몇 kg으로 살이 빠지셨나요?
Ex	이전에도 이렇게 살이 많이 빠진 적이 있나요?
C	현재 키, 몸무게, 허리둘레는 어떻게 되나요? 인위적으로 체중 감소를 위해 운동량/식사량 조절을 하셨나요?
A	[전신] 발열/오한/피로 [흡수 부족] 씹는데 장애가 있으신가요? [호흡기(결핵/폐암/COPD)] 기침(C)/가래(S)/객혈(H)/호흡곤란/야간 발한(NS)/목아픔(S)/숨참이 있나요? [소화기(위암/대장암)] 복통(A)/오심(N)/구토(V)/설사(D)/변비(C)/속쓰림(H)/소화불량(D)/토혈(H)/흑색변(M)/혈변(H)/지방변이 있나요? [정신 - 우울증] 우울/불안/의욕 저하가 있나요? [신경성 식욕부진] 본인의 체형에 대해 어떻게 생각하시나요? 스스로 뚱뚱하다고 생각하시나요? 일부로 구토를 한 적이 있나요? [암기법] 체중 감소로 온 환자가 씹질 못해 전신 흡수 부족을 호소하며 정신의 내분이 일어났다. [설명] ANVDC HD HMH 형태 [갑상샘항진증] 더위불내성/두근거림/설사가 있나요? [크론친화세포증] 두통/두근거림/발한/기립성 저혈압이 있나요? [당뇨] 다음/다갈/다뇨가 있나요? [암기법] 내분비 과다로 갑자기 크당
F	[가생충] 해외 여행을 다녀오셨나요? 최근에 스트레스 받는 일이 있나요?
E	이전에 건강 검진 받은 적 있나요? → 위내시경/대장내시경 받아 보았는지?